Директору
ТО Ленинское

Отчет о посещении
ТО Ленинское, ЖК-2.

Дата посещения: 05-06.08.2026г.

Цель: Оценка эффективности работы сокращению маститных животных в стаде, оценка здоровья и технологии выращивания молодняка.

Общая информация:
Общее поголовье КРС — 2145гол.
Коровы дойные — 861гол.
Сухостойные животные — 151гол.
Родильное отделение — 40гол.
Маститная группа — 62гол.
Доильный зал — Карусель Елочка GEA внутренняя 28 мест.
Доильный зал Родильное отделение — 2 бачка.
Средний удой\гол — 30,5л.
СКК танка — 195-200 тыс/мл.
СКК маститная группа — 750 тыс/мл.
Бактериальная обсемененность — не проводится.
Режим доения — 3 раза/сут.

Входе посещения было выявлено:
-В смене работают 3 дояра. В первую очередь происходит сдаивание первых струек на пол, кружки для сдаивания первых струек не применяются, в результате чего не каждый случай мастита может быть выявлен, дополнительно к этому, данный метод работы приводит к повышению бактериальной обсемененности доильного зала. Далее для преддойной обработки применяется скруббер для очистки сосков. Средство используемое со скруббером VIOVIT, в инструкции данного средства не указана возможность применения совместно со скруббером, концентрация средства не может обеспечить возможность проведения эффективной промежуточной дезинфекции щетин скруббера, что повышает риск переноса возбудителей мастита от животного к животному.
В дальнейшем происходит подключение подвесной части доильного аппарата. По окончанию доения производится постдиппинг с полным окунанием соска в средство Комбовит.
-Доильное оборудование в удовлетворительном состоянии, в недавнем времени производилась замена сосковой резины, коротких вакуумных шлангов, однако выяснить периодичность технического обслуживания доильного оборудования нет возможности, никто не смог предоставить информацию. Журнал о проведении технического обслуживания, ремонтных работ не ведется.
Уровень вакуума согласно показаний манометра 40кПа. Замер частоты пульсации не проводится. Со слов специалистов мойка доильного оборудования происходит с

чередованием щелочных и кислотных средств, однако какой режим мойки установлен, концентрация моющих средств, температурные режимы, объем воды, время мойки информация отсутствует.
-Выявлением клинической формы маститов животных занимаются дояры. Диагностика на субклинические маститы не проводится. 1-3 раза в месяц проводится диагностика с применением Кенотеста только у маститной группы.
Маститная группа на комплексе 62 головы.
Раздельный учет клинической, субклинической формы маститов не ведется, отдельный журнал по контролю маститных животных в стаде не ведется.
Вновь выявленных в процессе доения маститных животных переводят в отдельную группу, которая доится в последнюю очередь. Лечение этим животным не применяется.
Проведя анализ по данной группе животных можно сделать следующее заключение: часть животных, 15 голов являются стародойными с низкой продуктивностью, часть животных, 8 голов, животные с хронической формой мастита, которые возвращаются в данную группу 3-4 раз, которые просто находятся длительное время в данной группе. Целесообразности нахождения их в этой группе нет, необходимо уточнить стельность, либо запустить, либо выбраковать.
-Запуск животных производится путем применения препарата Мамифорт Секадо, внутрицистернальный герметик соска не применяется. Подбор препарата согласно антибиотикочувствительности не применяется.
Согласно данных полученных от специалистов, у 8-10% новотельных животных выявляется мастит.
-При осмотре конечностей визуально наблюдается большое количество животных с выраженной хромотой, язвами, травмами копытец.
-В родильном отделении расположена секция для доения новотельных животных. В секции находится 40 голов, однако новотельных животных там только 8, остальные животные это животные с болезнями конечностей. Недопустимо содержание новотельных животных с больными животными.
Доение в данном отделении производится при помощи двух бачков. Доильное оборудование чистое, однако имеются трещины на коротких вакуумных шлангах, манометр для показаний вакуума в системе не исправен, данные о техническом обслуживании отсутствуют.

Выводы:

На данном МТК клинический, субклинический мастит выше нормы — 7,2 % (62 головы). На данный момент можно предположить что хронического резервуара субклиники в стаде нет. Соматические клетки в общем молоке стабильно держатся на уровне 195–200 тыс./мл. Массовой скрытой инфекции по стаду нет: основная масса коров здорова. Проблема не в накопленном резервуаре хроников, а в текущем потоке клинических случаев.

Такое сочетание — высокая клиника при умеренном СКК — типично для инфекции, которая быстро даёт острое воспаление, но не оставляет длинного субклинического давления. Это может быть экологический возбудитель (E. coli,

Strep. uberis, Klebsiella — из среды и подстилки) либо контагиозный, который в хозяйстве успевают гасить клинически, но не устраняют причину заражения. Различить их можно только бактериологией, т.е. при помощи лабораторной диагностики.

Где может закладыватся инфекция. Первое — сухостой: герметик соска не применяется, антибиотик сухостоя не применяется, подбор препарата для запуска согласно подтитровки не применяется. Второе — момент доения, обработка соска через общий скруббер со средствами которые не могут обеспечить моментальную дезинфекцию. При этом ряд вещей на ферме сделаны правильно — сдаивание первых струек до обработки, полный постдиппинг, автоматическое снятие аппаратов, вакуум в норме 40 кПа, порядок доения «больные последними», карантин пополнения.

Что мешает управлять маститом. Клинический мастит **не лечится**, именной журнал не ведётся, бактериология и определение возбудителя не проводятся. Мастит регистрируется, но ни лечения, ни учёта, ни причины по ним нет.

Рекомендовано:

1. Разработка программы по гигиене доения:

Сдаивание первых струек — в чашку, не на пол, более качественный способ выявления маститов, одновременно прекращение разбрызгивания инфицированного молока в зоне доения.

Провести подбор средств до и после доения согласно требований применяемого оборудования.

2. Проведение диагностики работы доильного оборудования с последующим устранением выявленных неисправностей и недостатков.

3. Произвести лабораторную диагностику проб молока от животных с выявленным клиническим и субклиническим маститом с целью выявления возбудителя мастита в стаде, а также для определения чувствительности выявленной микрофлоры к антибактериальным препаратам. Обязательная диагностика на контагиозные возбудители: Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma bovis. Это определяет всю дальнейшую стратегию.

Лабораторное исследования молока от коров с воспалением молочной железы необходимо проводить не реже одного раза в квартал, а при снижении эффективности лечения не реже одного раза в месяц или исследовать каждый новый случай мастита.

4. Составление полноценных схем лечения маститных животных согласно полученных результатов лабораторной диагностики.

5. Ежемесячно проводить контроль молока от каждой коровы на содержание уровня соматических клеток. Такая частота исследований позволяет отследить животных с постоянно высоким его уровнем, что может свидетельствовать как об особенностях организма животного, так и указывать на наличие хронического воспаления молочной железы.

6. Завести журнал маститов с раздельным учётом клинических и субклинических форм, датами, четвертью, исходом. Это база, без которой нельзя измерить эффект любых мер.
7. Провести анализ по заболеваниям конечностей крупного рогатого скота в данном хозяйстве:
- проведение ортопедического мониторига;
- разработка программы лечения и профилактики заболеваний конечностей животных.

Молодняк, схема противоэпизоотических, профилактических меропиятий.

Технологически выращивание телят на ЖК-2 поставлено неплохо: молозиво выпаивается в первый час, есть банк молозива и контроль пассивного иммунитета, ЗЦМ пастеризуется, стартер с первого дня, содержание и микроклимат в норме, вакцинация выстроена. На этом фоне выделяются несколько проблем: диарейный синдром у 25-30% телят в возрасте 0-30 дней, респираторные заболевания у 15% молодняка, пик заболеваемости 15 дней — 1,5 месяца, с учетом применения Тулатромицина с рождения, средний среднесуточный привес 0-60 дней 670 грамм.

1. ***Диарея 25–30 % в первые три недели — главная проблема.*** При этом причины лабораторно не установлены («основные причины диареи — нет»), лечение назначается по цвету кала, а оральная регидратация не проводится. Между тем именно обезвоживание, а не сам возбудитель, убивает телёнка при диарее.

2. ***Тулатромицин с рождения однократно всем телятам.*** Метафилактическое применение антибиотика длительного действия поголовно, без клинических показаний, — это выращивание антибиотикорезистентности и удар по формирующейся микрофлоре кишечника. При диарее 25–30 % и пневмонии 10–15 % понятно желание «прикрыть» телёнка, но такой подход маскирует проблему, а не решает её.

3. ***Молозивный статус — на нижней границе.*** Общий белок сыворотки 5,5 г/дл — это порог ниже которого начинается недостаточная передача иммунитета. То есть запаса нет, и часть телят почти наверняка ниже порога. Качество молозива оценивается колострометром с минимальным значением «1025», а это уже зона неуверенного качества (хорошее молозиво — плотность от 1,045–1,050).

4. ***Автоматическая станция выпойки.*** По данным полученным от специалистов данного МТК, после установки станции телята визуально мельче, а привесы упали с 700–750 до 600–650 г. Это важный сигнал: либо станция недодаёт норму, либо есть проблема доступа/конкуренции. Требует отдельной проверки настроек и потребления.

5. ***Падеж составляет 7,7%, что является верхней границей допустимого***. Падеж сосредоточен в первые 30 дней (30 из 39 голов). После первого месяца телята выживают уверенно. Значит вся проблема — в связке «молозиво → ранняя диарея → обезвоживание», и работать надо именно там. Причины падежа

перечислены (энтерит, пневмония, перитонит, тимпания, казеино-безоарная болезнь), вскрытия проводятся, но без лабораторного подтверждения возбудителей, остаётся «слепой» диагноз.

6. ***Молозивный период.*** Первая выпойка в течении 1 часа, объем 3-3,5литра(10% от массы), зондирование, объем за 24 часа 5,5 литров 2 раза, что ниже является ниже нормы, необходимо 8-10% 3-4 выпойки. Контроль пассивного иммунитета проводится на 3 день, средний показатель общего белка 5,5, ровно на допустимом пороге, запаса нет. При таком показателе примерно половина телят оказывается ниже порога, то есть с недостаточной передачей иммунитета. Именно эти телята и дают львиную долю диареи 25–30 % в первые три недели.

Необходимо обратить внимание на качество молозива, кратность и объем выпойки в первые 24 часа.

7. ***Кормление.*** После молозива выпаивается ЗЦМ Eurolac Grün, 0,42 кг порошка на 3 л раствора, дважды в сутки, пастеризация, температура 38–40 °C. Стартер «Кальвостарт» (ЗАО «Консул») с первого дня, вода с рождения.

Объем ЗЦМ 6 литров в сутки, требует обсуждения с специалистом по кормлению. Потребление стартерного комбикорма не отслеживается. Отъем в 60 дней.

8. ***Лечение, метафилактика.*** Лечение диареи назначается по цвету кала («чёрный — Витом + Диаракс, жёлтый — Ветом + Бутофан»), без лабораторного определения возбудителя. Необходима лабораторная диагностика.

Оральная регидратация не проводится. При диарее телёнок гибнет от обезвоживания и ацидоза, а не от инфекции как таковой. Электролитные растворы (оральные регидратанты) необходимы.

Тулатромицин с рождения всем телятам однократно. Поголовная метафилактика антибиотиком длительного действия без клинических показаний мера от которой следует уходить. Она: (1) уничтожает формирующуюся нормальную микрофлору кишечника, что само по себе способствует диарее; (2) выращивает антибиотикорезистентность, из-за которой реальные инфекции потом лечатся хуже; (3) маскирует недоработки молозивного и санитарного блока, вместо того чтобы их устранять.

9. ***Вакцинация.*** Схема выстроена подробно и в целом грамотно: стельные коровы — Ротавек Корона за 60 дней до отёла (материнская защита от рота/коронавируса и E. coli), телята — Инфорс интраназально на 3-й день (ИРТ/ПГ-3/РСВ), BoviShield Gold на 28-й и 56-й день (BVD, ИРТ, ПГ-3, РСВ), Ваншот Ультра с 14-го дня (пастереллёз, клостридиозы).

Однако со слов специалистов периодически наблюдаются вспышки заболеваний как с диарейным синдромом, так и с респираторным синдромом. Периодически проявляются признаки острых респираторных инфекций, покрасневшее носогубное зеркало, риниты.

Для уточнения, исключения, установления причин данных проявлений необходимо провести дополнительную лабораторную диагностику.

Рекомендовано:

1. Выполнить бактериологические и ПЦР исследования тканей пищеварительного тракта от павших и/или вынужденно убитых телят для установления / исключения инфекций.
2. Провести серологическое исследование проб сыворотки крови на основные вирусные инфекции (ИРТ, ПГ-3, РСИ, ВД), для установления вирусного статуса стада.
3. Скорректировать схему ветеринарно-профилактических мероприятий согласно результатов лабораторной диагностики.
4. На основании результатов диагностической работы, предложить схему антибиотико-, вакцинопрофилактики молодняка разных возрастных групп.
5. Ввести оральную регидратацию при диарее.
6. Пересмотреть поголовную метафилактику тулатромицином.
7. Усилить контроль за молозивом.
8. Организовать изолятор для больных телят.

Ветеринарный врач ЗАО Консул
Зуборев К.В.